Ch. 12 – Prise de notes

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques · tout le cours en prise de notes

Abréviations : AT = alimentation thérapeutique · FT = fiche technique · CNO = complément nutritionnel oral · DADFMS = denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales · ETP = éducation thérapeutique du patient · CG = charge glycémique · → = donne / entraîne · ≠ = différent de

Corrections CNED : « régime diabétique / hyposodé » → **alimentation contrôlée en glucides / en sel** (sur prescription) · **SFNCM** et non « SNFCM » · ETP **déclarée** à l'ARS depuis le **1/1/2021** (**décret 2020-1832**) ; 40 h : arrêté **2/8/2010**, modifié 2013 et 30/12/2020 · dénutrition : **HAS 2019** (< 70 ans) et **2021** (≥ 70 ans) ; CNO : **HAS 2007**.
Repères CNED : régime imposé, dégustation **sans risque** (« sans sel strict » salé = faute grave) · mixé **≤ 30 min avant** le service · manger-main · pas de glaçage ni caramel en contrôle glucidique.

1. Cadre et démarche (12.3.1)

- AT = **prescription** ou préconisation (BC1) ; l'atelier **adapte**, ne prescrit pas ; variantes **discrètes**, **secret**.
- **5 étapes** : prescription → cible → techniques (**substituer, réduire, enrichir, modifier la texture**) → vérification → **dégustation**.
- FT : rubrique **« variantes »** : point de **prélèvement**, ajout, **identification** (couleur), valeurs par portion. **Jamais le nom** sur la FT.
- Ciqual : **même état** (cru/cuit) ; apport = poids × teneur / 100 ; traces = 0 **signalé** ; riz cru pour cuit = **+ 133,5 %** → hypoglycémie.
- Hygiène : mixeur **démonté-désinfecté**, mixer chaud et servir, 63 → < 10 °C **< 2 h**, **0-3 °C**, remise ≥ 63 °C **< 1 h**, plats témoins.
- Évaluer : **mangé ?** (restes, suivi 3 j) ; smileys = **politesse** (3,9/5 mais 40 % de restes). Mixés moulés : restes **30 → 13,8 %**.
- **Mixer sans diluer** : bœuf 32,1 → **20,4 g** au bouillon (**− 36 %**) ; lait + poudre 22,2 g.

2. Textures (12.3.1)

- Dysphagie → fausses routes, pneumopathie, dénutrition ; niveau fixé par l'**équipe** (orthophoniste).
- Déglutition : **oral** · **pharyngé** (réflexe) · **œsophagien**. **Textures mixtes** = danger.
- Alerte : **toux**, **voix mouillée**, aliments gardés en bouche, infections → **signaler**. Assis, tête **un peu en avant**, rester assis 30 min.
- **IDDSI (2016)** : **0-7** ; boissons **0-4**, aliments **3-7** ; 3 liquidisé · 4 mixé lisse · **5 haché lubrifié 4 mm** · **6 petits morceaux 1,5 cm** · 7 normal.
- Seringue **10 mL, 10 s** : < 1 / 1-4 / **4-8 (niv. 2)** / > 8 mL. Fourchette, cuillère, pression (**ongle blanchit**). **Chaque lot**, à température de service, **tracé**.
- Épaississant **amidon** : continue d'épaissir, **amylase** → au moment ; **xanthane** stable. Pas de **paille**.
- Eau ≈ **30 mL/kg/j** (55 kg → 1 650 mL ; journée à 64 %).
- Présenter : mixer **séparément**, **mouler** (agar ≈ 85 °C ; **gélatine fond** = texture mixte), couleurs, napper, assaisonner à la fin.
- Enfant : raisins **en quatre**, **pas de fruits à coque entiers avant 4-5 ans** ; niv. 5 = 2 mm, niv. 6 = 8 mm.

3. Sel (12.3.1)

- **Sel = sodium × 2,5** ; **OMS 2012 < 5 g** ; HTA, insuffisance cardiaque, rein.
- Sel caché (pain, charcuterie, fromage, **bouillon cube**) · fait maison · aromates · **saler à la fin en surface** · paliers.
- Bouillon cube 1,25 → **0,25 g**/portion ; pizza **− 65,2 %** (pâte = ½ du sel) ; sandwich − 47,7 % (pain = 1re source).
- **1924/2006** : pauvre **≤ 0,12 g Na** · très pauvre ≤ 0,04 · sans ≤ 0,005 · **réduit − 25 %** (reste salé).
- Âgé : pas de sans sel strict inutile → **dénutrition**. **Arrêté 30/9/2011** : sel non en libre accès à la cantine.
- « Trop de régimes tue le régime » : prescription **actuelle**, revue **tous les 3 mois**.
- Atelier « goût sans sel » : habitudes → deviner → **aveugle** → cuisiner → transférer → évaluer.
- **DASH** (Appel 1997 ; Sacks 2001) ; **potassium** dangereux si **insuffisance rénale**.

4. Glucides (12.3.1)

- Pas de « sans sucre » : **répartir**, fibres, **al dente**, associations, portions.
- Type 1 = **insuline à vie** ; type 2 = **résistance** ; gestationnel = fractionner.
- **Hypo < 0,70 g/L** : **15 g** (3 sucres n° 4 ou 150 mL de jus) → **15 min** → recontrôler → glucides lents ; **15** si ne peut avaler ; **pas de chocolat**.
- **Assiette** : ½ légumes, ¼ féculents, ¼ protéines. Pâtes 150 g **47,1 g** ; riz 150 g **49,8 g** ; pain 50 g 29,2 g.
- **CG = IG × glucides / 100** (< 10 faible ; > 20 élevée) ; lentilles 10,4 · pâtes 23,1 · pain 33,2. IG = **tendance**.
- Desserts **en fin de repas**, − 25-50 % ; clafoutis sucre ÷ 2 → sucres **− 29,4 %**. Édulcorants : ANSES 2015, **OMS 2023**.
- « Sans sucres » ≤ 0,5 g mais **amidon** ; « sans sucres ajoutés » = sucres naturels ; réduit **− 30 %** ; polyols > 10 % laxatifs.

5. Lipides (12.3.1)

- Qualité : ↓ saturés, ↑ colza, olive, noix ; poisson gras. Fromage blanc **hors du feu**.
- Colza ω-3 · **noix, lin crus** · olive cuisson douce · tournesol en alternance · beurre brûle **120-130 °C** · huile qui fume = **acroléine**.
- **ANSES 2011** : lipides **35-40 %**, saturés **≤ 12 %**, ω-6/ω-3 < 5, **EPA + DHA 500 mg**. **1 g = 9 kcal**.
- % AGS = AGS × 9 / kcal × 100 : gratin **32,8 → 13,4 %**.
- Maquereau 2 568 mg · sardines 1 770 · **thon 472** ; semaine 3 500 mg. Grands prédateurs évités (enceintes, enfants).
- Méditerranéen : **Lyon 1994/1999**, **PREDIMED 2013/2018**.

6. Sans gluten (12.3.1)

- Cœliaque = **auto-immune**, éviction **à vie** (blé, épeautre, seigle, orge, avoine non garantie).
- **828/2014** : sans gluten **≤ 20 mg/kg** ; très faible ≤ 100 ; épi barré ; AFDIAG.
- Contamination : **en premier**, pas de farine dans l'air, ustensiles, friture séparée. Caché : soja, malt, bière, chapelure. Sirop de glucose de blé **exempté**.
- Gluten : gliadines + gluténines → remplacer par **xanthane, psyllium**, œufs, moule, mélange de farines.
- **Naturellement sans gluten** = moins cher : panier 11,85 € vs 23,25 €.

7. Allergies (12.3.1)

- Allergie (IgE, protéine, **anaphylaxie**) ≠ cœliaque (auto-immune) ≠ **intolérance au lactose** (lactase, **jamais de choc**) ≠ syndrome oral ≠ **latex-fruits**.
- Lactose toléré **≈ 12 g** (EFSA 2010) ; fromages affinés ≈ 0 ; yaourt mieux toléré.
- **14 allergènes** (1169/2011) ; écrit : **décret 2015-447**. « Peut contenir » = **volontaire** ; suivre le PAI.
- Remplacer la **fonction** : œuf → fécule, compote, **aquafaba** ; boisson végétale **≠ lait** pour un jeune enfant.
- Atelier sûr : recueillir → **sans l'allergène pour tous** → acheter soi-même, garder les emballages, **refuser les denrées apportées** → poste propre → trousse → traçabilité.
- Anaphylaxie : **adrénaline face externe de la cuisse**, **15 toujours**, assis ou allongé jambes surélevées.

8. Enrichissement (12.3.1)

- Dénutrition : **1 phénotypique + 1 étiologique**. Perte **5 %/1 mois, 10 %/6 mois** ; IMC **< 18,5** (2019) / **< 22** (≥ 70 ans, 2021) ; apports − 50 % > 1 sem.
- Sévère : IMC ≤ 17 (< 20 après 70 ans) ; − 10 %/1 mois, − 15 %/6 mois ; albumine ≤ 30 g/L.
- **Surpoids + perte = dénutri possible** (Mme V. IMC 27,4, − 12,2 %).
- Enrichir **sans volume**, avant les CNO : lait en poudre 10 g = 3,5 g ; fromage 20 g = 5,5 g ; œuf = 6 g. **Pas que du gras**.
- 7 gestes = **+ 370 kcal, + 23 g**. Riz au lait enrichi **10,8 g** vs 3,8 g industriel ; 0,40 €.
- **5-6 prises** ; jeûne nocturne **≤ 12 h**. 10 g de protéines : lentilles 0,12 € → jambon 0,62 €.

9. DADFMS, CNO (12.3.2)

- **609/2013** + **2016/128** ; sous contrôle médical ; complets / incomplets ; **LPPR**.
- CNO (**HAS 2007**) : **+ 400 kcal et/ou 30 g/j**, **2/j**, **à distance des repas** ; 1re prescription ≤ 1 mois, renouvellement ≤ 3 mois.
- Hyperénergétique **≥ 1,5 kcal/mL** ; hyperprotidique **≥ 20 %** de l'énergie.
- Mme P. : gain réel ½ de l'énergie prescrite → **10 h et 16 h**. Suivre la **consommation réelle**.
- Atelier : CNO **seulement si prescrit** ; phénylcétonurie → centre de référence ; aucune improvisation.

10. ETP (12.3.3)

- ETP : patients, **L. 1161-1**, **déclarée ARS**, **40 h**, **diagnostic éducatif**.
- Compétences **d'autosoins** et **d'adaptation** (HAS 2007) ; objectif **du point de vue du patient**.
- Posture : **entretien motivationnel** (Miller et Rollnick 1991) : questions ouvertes, valorisation, reformulation, résumé, permission.
- Outils : photolangage, cartes-aliments, métaplan, jeu de rôle, étiquettes. Évaluation : compétences → quotidien → vécu → clinique.
- Tilleuls : un menu, **3 variantes discrètes** ; bilan **sécurité, inclusion, plaisir**.

11. Approfondissements, L3, jury (12.4-12.6)

- Manger-main : ne s'émiette pas, ne coule pas, **dense** ; mini-cakes 115 kcal, 5,2 g.
- Goût métallique → **couverts plastique** ; anosmie → **dates et gaz**.
- Restaurant : sauce à part, sans sel ajouté, **liste des allergènes**.
- **Recette commune** : classer contraintes (tous / variante) → prélever → calculer → FT.
- Végétarien : lysine / méthionine sur la journée ; **25-30 g/repas** ; végétalien → **B12**.
- L3 : **Jenkins 1981** (IG) · **PROT-AGE 2013** (1,0-1,2 / 1,2-1,5 g/kg) · **LEAP 2015** (17,2 vs 3,2 %) · IDDSI 2013 → 2016.
- Pain perdu Parkinson **+ 39 %** protéines, 0,29 € · poulet coco **55,6 g** de glucides, 1,41 € · Ramadan : iftar **− 29 %**, rompre si < 0,70 ou > 3,00 g/L.
- Jury : prescription · recette commune · gestes précis · calculs sourcés · sécurité · plaisir · secret · **limites du rôle**.